

42 - 01-Révision sémiologie ORL + surdité (Teams) - Pr. Raji

(0:00 - 9:23)

Est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. Oui, très bien. Bien, alors aujourd'hui, on va faire un cours interactif concernant les cours de sémiologie que j'ai eu le plaisir de vous enseigner dans le cadre des cours de deuxième année des études médicales.

Alors, on va commencer par le cours sur les surdités et on va commencer déjà par la définition. Qu'est-ce qu'on entend par surdité? C'est quoi la surdité selon vous? Bien, alors je vois qu'il n'y a pas de réponse. Alors la surdité, c'est une baisse de l'EI qui va être secondaire à une atteinte d'une partie de l'appareil auditif, ce qui supposerait à ce moment-là que l'on sait très bien ce que c'est qu'un appareil auditif et qui peut soit toucher l'appareil de transmission, soit l'appareil de perception.

Ce qui nous amène à une deuxième question, quelles sont les parties de l'appareil auditif qui sont atteintes dans une surdité de transmission et quelles sont les parties de l'appareil auditif qui peuvent être touchées dans les surdités de perception? Vous écrivez vos commentaires, s'il vous plaît, sinon il y aura une interférence de son. Vous partez sur la conversation et vous écrivez votre réponse. Surdité de transmission, oreilles externes et moyennes.

Oui, c'est juste. Et dans la perception, c'est quoi? Oreilles internes, pas seulement. Quoi d'autre? L'oreille interne, les aires auditives et les nerfs.

L'oreille interne, les voix auditives et les aires auditives. Quand vous le voyez sur cette diapositive, vous voyez ici l'appareil auditif avec le conduit auditif externe sur lesquels c'est schématisé les vibrations sonores qui va faire vibrer la membrane en temps panique, bouger la chaîne ossiculaire et puis les liquides labyrinthiques au niveau de l'oreille interne pour créer un influx nerveux qui part vers les nerfs auditifs et puis vers les centres auditifs. Donc toute atteinte de l'oreille externe ou de l'oreille moyenne peut être à l'origine d'une surdité de transmission et toute atteinte de l'oreille interne, des voix auditives ou des centres auditifs, donc des aires temporales, peut être à l'origine d'une perception.

Alors comment on peut dans ce cadre-là, dans le cadre des surdités, réaliser des épreuves de Rihn et de Weber? C'est-à-dire en quoi ils consistent. Alors ceci nous l'avons déjà étudié, l'épreuve de Weber est une épreuve comparative au niveau des deux oreilles et qui va demander l'utilisation d'un diapasant qu'on va faire vibrer au niveau des branches et qu'on va mettre sur le plan de son pied sur le vertex et on va demander aux patients de quel côté ils l'entendent. Est-ce qu'ils l'entendent mieux d'un côté ou de l'autre ou ils l'entendent de la même façon des deux côtés? Et en fonction des réponses, en fonction du côté sourd, on pourra tirer des conclusions.

L'épreuve de Rihn est une épreuve comparative mono-auriculaire entre la conduction osseuse, vous voyez là le pied du diapasant est posé sur la mastoïde et ici les branches du diapasant qui

ont vibré et sont posées devant l'oreille. Donc ici on explore la conduction aérienne et là on explore la conduction osseuse et à ce moment là on posera la question aux patients quelle est la meilleure audition? Est-ce que c'est celle qui concerne la conduction aérienne ou celle qui concerne la conduction osseuse? Alors quels sont les résultats à votre avis connaissant maintenant les épreuves de Rihn et de Weber dans la surdité de transmission et dans la surdité de perception? Résultat des épreuves de Rihn et du Weber dans la surdité de transmission. Résultat de l'épreuve de Rihn et du Weber dans la surdité de perception.

Weber latéralisé du côté sourd, oui, et le épreuve de Rihn est négative. Qu'est ce que ça veut dire épreuve de Rihn négative? Ça veut dire que la conduction osseuse est supérieure à la conduction aérienne. Donc dans la transmission le Weber est latéralisé du côté sourd et l'épreuve de Rihn est négative.

Et dans la perception quels sont les résultats? Dans la perception les résultats seraient différents. Par conséquent le Weber sera latéralisé du côté sain et le Rihn sera positif. Ça veut dire que la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse.

Mais là se pose bien sûr une question. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi dans une surdité de transmission on trouve à l'épreuve de Rihn une conduction aérienne supérieure à l'osseuse, une conduction osseuse supérieure à l'aérienne? Et pourquoi dans une surdité de perception on trouve à l'épreuve de Rihn la conduction aérienne supérieure à la conduction osseuse, c'est à dire l'inverse? Et pourquoi dans une perception unilatérale l'épreuve de Weber est latéralisée du côté sain? Et pourquoi dans la surdité de transmission unilatérale l'épreuve de Weber est latéralisée du côté sourd? C'est à dire en d'autres termes la réponse que vous avez donnée, est-ce que vous arrivez à l'expliquer? C'est à dire arriver à dire de quoi vraiment il s'agit sur le plan de l'explication, du pourquoi de la chose. Alors il y a quelqu'un qui me dit dans les surdités totales, c'est à dire au moment où la personne n'entend plus rien, quel serait le résultat de l'épreuve de Rihn? Il se peut qu'il y ait de très grosses difficultés de pouvoir avoir une réponse à partir du patient lorsque la surdité est totale, mais en général lorsque la surdité est totale, c'est ce qu'on appelle la kophose, c'est une perception qui est responsable de ce type de surdité.

(9:27 - 10:27)

Pourquoi est-ce que le Weber est latéralisé du côté sain et le Rihn est positif dans la perception et pourquoi est-ce que le Weber est latéralisé du côté malade et le Rihn est négatif dans la transmission? La conduction aérienne explore le rayon externe et moyenne, si on est devant une surdité de transmission, la conduction aérienne va être inférieure par rapport à la conduction osseuse. Votre phrase est fausse parce que la conduction aérienne explore tout l'appareil auditif, l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne, les voies auditives et le centre auditif. Par contre la conduction osseuse n'explore que l'appareil de perception, c'est à dire l'oreille interne, les voies auditives et les centres auditifs.

(10:29 - 10:56)

La réponse est que la conduction osseuse est normalement supérieure à la conduction aérienne, c'est faux. Donc il y a une surdité avec conduction osseuse supérieure. Le problème ne vient pas de la perception mais de la transmission, donc surdité.

Dans la surdité de transmission, il y a un obstacle. Dans l'oreille, ce qui altère la transmission aérienne, donc l'épreuve de Rinne sera négative. Relativement juste mais pas trop juste.

(11:02 - 19:42)

Il faut comprendre que l'épreuve de Rinne est une épreuve comparative entre la conduction aérienne et la conduction osseuse, comme vous voyez ici dans le cadre de la surdité de transmission, où l'appareil de transmission étant touché, par conséquent la transmission ne sera pas assurée d'une part lorsqu'on présente le diapason devant l'oreille et deuxièmement il n'y aura pas les phénomènes d'amplification engendrés par le conduit auditif externe et par le tympan et la chaîne ossiculaire. Ce qui fait que la conduction osseuse qui elle explore l'appareil de perception, qui dans la transmission est tout à fait normale, va être sentie supérieure à la conduction aérienne. Par contre le contraire va être trouvé, on sait que dans la perception les éléments qui seraient touchés sont à partir de l'oreille interne, voie auditive ou centre auditif, donc par conséquent la conduction osseuse va être vue en baisse, elle va chuter.

Et c'est ce qui fait que la conduction aérienne qui normalement a bénéficié d'une amplification du conduit et de la chaîne ossiculaire dans le brin tympanique serait toujours supérieure à la conduction osseuse. Dans l'épreuve de Rinne les explications de la conduction osseuse supérieure à l'aérienne dans la transmission c'est ça, ce que je viens de vous expliquer, et bien sûr le contraire se verra dans la surdité de perception. Voilà un exemple pour que vous puissiez comprendre.

La flèche bleue c'est la conduction aérienne, vous voyez l'obstacle, il fait vibrer le tympan. Par exemple ici où il y a une absence de chaîne ossiculaire, c'est une transmission par l'absence d'un élément de la chaîne, il va être responsable d'une diminution de la conduction aérienne alors que la conduction osseuse reste tout à fait normale et c'est ce qui fait que la conduction osseuse serait supérieure à la conduction aérienne. Alors qu'en dit-il maintenant de l'épreuve de Weber ? C'est une épreuve comparative entre les deux oreilles, c'est une comparaison des deux oreilles en même temps et donc qu'est-ce que la conduction osseuse ? Ça veut dire la vibration au travers de l'os du crâne directement partant vers la stimulation de l'oreille interne.

Ce qui se passe dans la transmission c'est que l'énergie sonore va se concentrer sur l'oreille interne, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de déperdition vers l'extérieur par contre au contraire, par voie aérienne et donc c'est cette concentration d'énergie au niveau de l'oreille interne qui va faire sembler au patient qu'il entend mieux du côté de la surdité de transmission. Par contre, dans la surdité de perception où il y aura toujours une déperdition, le patient entendra mieux du côté normal. Vous avez ici les explications par exemple dans la perception ou dans la transmission, nous reprenons toujours pour simplifier l'explication l'absence d'un élément de la chaîne ossiculaire ou bien sûr vous avez une transmission et la vibration engendrée par la

vibration du diapason au niveau du vertex va aller se concentrer au niveau de l'oreille interne sans aucune déperdition vers l'extérieur et donc chez ce patient là ayant une surdité de transmission unilatérale gauche, le patient va vous dire j'entends mieux du côté gauche donc il entendra du côté malade.

Par contre dans la perception où la déperdition en énergie est toujours la même, bien sûr la vibration va aller de l'autre côté aussi, elle va aller du côté droit où le patient a une perception mais aussi du côté gauche où le patient n'a pas de surdité et c'est ce qui fait que du moment que c'est l'appareil de perception qui est touché au niveau gauche il y aura une audition en conduction osseuse tout à fait normale du côté gauche et bien entendu à ce moment là le patient dans l'épreuve de Weber va avoir une audition normale, du côté normal dans la surdité de perception et c'est bien entendu votre réponse de début qui dit que dans la surdité le résultat de la comitree instrumentale c'est à dire le diapasant pour une oreille saine, ceci vous le savez, le Weber est indifférent et le RIN est positif, pourquoi? Parce que la conduction aérienne étant toujours supérieure à la conduction osseuse, bénéficiant des amplifications au niveau de l'oreille externe et moyenne, dans la transmission le Weber est latéralisé du côté malade et l'épreuve de RIN est négative et bien sûr dans la perception elle est latéralisée du côté sain, donc le Weber est latéralisé du côté sain et l'épreuve de RIN est positive. Après ces différents éléments, nous allons partir sur des données cliniques, ici vous avez un enfant de 8 ans qui se plaint d'une surdité bilatérale, donc il répond à la définition de la surdité d'installation progressive depuis l'âge de 5 ans, il a 8 ans, 3 ans de surdité. En général on recherchera des éléments à l'interrogatoire qui vont faire évoquer le diagnostic étiologique de la surdité, quels sont ces éléments? En quoi consistera l'examen clinique chez ce patient pour l'approche diagnostique? Et quel est l'examen paraclinique qui va nous permettre de préciser quel est le degré de surdité et le type de surdité? Et bien bien entendu, quels sont les diagnostics étiologiques les plus probables chez ce petit enfant? 8 ans, depuis 5 ans il entend mal, des deux oreilles, quelles sont les questions qu'il faut poser aux parents, à l'enfant? Quel examen clinique va-t-on réaliser pour comprendre le diagnostic? Quels sont les examens paracliniques qui vont nous permettre de savoir quel est le degré de surdité et surtout le type et bien sûr quelles sont les étiologies.

Alors quel est l'interrogatoire? Antécédents de surdité au sein de la famille, oui bon c'est possible. Les signes accompagnateurs, un traumatisme, maladie, famille, oui. Antécédents pathologiques, otologiques vous voulez dire, il n'y a pas de HA otologique.

Donc antécédents otologiques, est-ce que son oreille coule, est-ce qu'il a des acouphènes, est-ce qu'il a des auralgies, est-ce qu'il a été opéré de l'oreille, est-ce qu'il a eu un traumatisme crânien et bien entendu est-ce qu'il a été traité pour une pathologie de l'oreille. D'accord, est-ce qu'il fait des vertiges et bien entendu est-ce qu'il y a un élément de surdité dans la famille. En d'autres termes nous sommes en train de penser à la surdité génétique.

(19:42 - 21:01)

Bon l'interrogatoire doit être le plus exhaustif possible, bien sûr otorrhées, otalogiques, etc. Et en quoi va consister l'examen clinique? Il va consister en une otoscopie. L'otoscopie en général va nous permettre de regarder le conduit auditif externe et la membrane tympanique qui sera le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de la caisse du tympan.

Et chez ce patient là, voilà ce que nous avons trouvé. Quelle est votre interprétation de ces images? Qu'est-ce que vous trouvez, que vous voyez de particulier au niveau de ces deux otoscopies? Alors ce que vous voyez dans ces otoscopies, c'est que tout simplement j'ai une membrane tympanique qui est, on va dire, relativement normale. Elle n'est pas inflammée mais je vois des bulles d'air derrière la membrane tympanique, ce qui veut dire qu'il y a du liquide dans la caisse du tympan.

(21:02 - 21:43)

Ceci au niveau de l'otoscopie de l'oreille droite et au niveau de l'oreille gauche, je vois qu'il y a une bulle d'air qui est suspendue avec présence de liquide apparemment visqueux à l'intérieur de la caisse en absence de phénomène inflammatoire. Ce n'est pas une otite moyenne aiguë, c'est une otite séromiqueuse. Quel est l'examen qu'on pourra bien sûr réaliser? On va réaliser un audiogramme pour voir d'une part la conduction osseuse aérienne pour chaque oreille et deuxièmement pour déterminer quel est le seuil auditif.

(21:43 - 22:10)

À votre avis, il s'agit de quel type de surdité? Vous voyez là, c'est l'oreille droite et ici vous avez l'oreille gauche. En abscisse, vous avez les fréquences du son à explorer et puis en ordonnée, vous avez les intensités partant de moins 10, 0, 10, 20, 30, etc. jusqu'à 120 décibels.

(22:15 - 23:15)

Quelle est votre interprétation de cet audiogramme? Surdité de transmission, transmission vu que la conduction aérienne dépasse les 20 décibels, transmission vu que cela dépasse 20 décibels, tampons anormaux et la conduction osseuse, comment est-ce qu'elle est? Conduction osseuse, c'est ce que vous voyez là en haut, en noir, elle est tout à fait normale parce qu'il est au dessus de la ligne des 20 décibels. Donc j'ai une situation où la conduction osseuse est normale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'appareil de perception est normal mais j'ai une surdité qui touche la conduction aérienne et donc j'ai quoi? J'ai une inversion de l'équilibre entre la conduction osseuse et la conduction aérienne, c'est une surdité de transmission bilatérale. Donc il s'agit d'une surdité de transmission bilatérale.

(23:16 - 32:09)

Est-ce que c'est une surdité légère, modérée, sévère ou profonde? Vous voyez que le maximum de la perte auditive va vers 45 décibels, d'accord? Si vous regardez très bien, 45, 30 décibels, etc. Et donc par conséquent je suis dans le seuil de degrés modérés pour cette surdité. Donc j'ai posé le diagnostic, je sais quel est le retentissement chez ce patient et bien entendu je vais

passer au deuxième cas clinique.

Alors vous avez un patient de 60 ans qui consulte pour une bilatérale surdité installation progressive depuis trois ans et dans ce cadre là on se pose toujours les mêmes questions. Quelles sont les données de l'interrogatoire pour approcher le diagnostic étiologique? Quel examen faut-il réaliser? Quel paraclinique permettant de déterminer le type de surdité et le degré de surdité? Et quel est le diagnostic le plus probable? Donc dans ce cadre là, bien entendu l'interrogatoire étant un interrogatoire stéréotypé mais qui pourrait être orienté par un certain nombre d'éléments. Vous avez déjà, c'est un sujet âgé donc on pense à une baisse de l'audition en rapport avec l'âge.

On posera les mêmes questions dans ce cadre là mais à ce moment là on cherchera la notion de traumatisme, de chirurgie de l'oreille, d'écoulement de l'oreille, des vertiges d'acouphènes ou des autalgies pouvant nous permettre une approche. S'il vous plaît fermez votre micro. Alors attendez, il y a quelqu'un qui ouvre son micro.

Il vaut mieux qu'il ouvre son micro. Alors on va continuer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire chez ce patient-là? Après l'interrogatoire, on va passer à l'examen clinique et lorsqu'on fait l'examen clinique otoscopique chez ce patient, on voit que les membranes tympaniques sont tout à fait normales.

Quel est l'examen paraclinique qu'il faut réaliser? Donc on pourrait éventuellement faire ici une acoumétrie laquelle va nous permettre de déterminer les résultats du Weber et bien sûr les résultats d'urine. Alors si je vous dis que le Weber chez ce patient-là est indifférent et que les épreuves d'urine en bilatéral sont positives, ça veut dire que la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse. Alors qu'est-ce qu'il aurait ce patient-là? Si l'épreuve de Weber dans ce cas clinique est indifférente et si l'épreuve d'urine est positive des deux côtés, quel serait votre diagnostic? Donc c'est une surdité de perception bilatérale, donc problème central non pas central on va dire, une perception bilatérale.

On réalise une audiométrie et l'audiométrie voilà ce qu'il nous montre. Quelle est votre interprétation de l'audiométrie tonale à droite et l'audiométrie tonale à gauche? La conduction osseuse est en croix, la conduction aérienne est en rang. La droite est en couleur rouge et la gauche est en couleur bleue.

Quelle est votre interprétation? Alors quelle est votre réponse? Conduction aérienne et osseuse sont toutes les deux sous la courbe du 20. Ça veut dire quoi? C'est une perception bilatérale. Le plus important c'est que les deux courbes étant collées l'une à l'autre, ça veut dire que nous sommes dans le chapitre des perceptions.

Si on veut encore affiner notre diagnostic, il touche les fréquences aigües et dans ce cadre-là le diagnostic le plus probable étant la prise bi-acousie. Alors un troisième cas clinique, 14 ans, qui se plaint de surdité maintenant unilatérale gauche d'installation progressive depuis l'âge de 10 ans. Quel est l'interrogatoire qu'il faut faire? Quel examen clinique faut-il faire? Quel examen

paraclinique et quelle est votre approche diagnostique? Quand on fait bien sûr, après l'interrogatoire et bien entendu les différents éléments de l'interrogatoire qu'il faut chercher, lorsqu'on a fait l'otoscopie, on a trouvé une oreille droite tout à fait normale et bien sûr au niveau de l'oreille gauche, nous avons détecté l'existence d'une perforation tympanique avec une inflammation de cette membrane tympanique.

Vous comprenez très bien que c'est une otite moyenne chronique avec perforation du tympan et bien entendu vous avez une surdité de transmission sur toutes les fréquences où la conduction osseuse est relativement située au-dessus de la courbe de la ligne des 20 dB et la conduction aérienne étant située en plus bas. Donc nous sommes dans une situation de surdité de transmission. Quel est le diagnostic? C'est facile, c'est une otite moyenne chronique avec perforation tympanique.

Un de vos camarades me dit mais comment est-ce que l'otite serromuqueuse va entraîner une surdité de transmission? Lorsqu'on a du liquide dans la caisse du tympan, la mécanique de la chaîne ossiculaire va être perturbée et donc la transmission serait affaiblie et donc s'il est affaibli j'ai une surdité de transmission. C'est comme dans ce cadre là aussi, si j'ai une perforation, la membrane tympanique ne va pas vibrer normalement et par conséquent j'aurai une surdité de transmission. Je passe rapidement aux otalgies.

Alors les diagnostics définissent une otalgie dans le terme otodémie et une otalgie dans le cadre des otalgies réflexes. C'est quoi une otodémie et c'est quoi une otalgie réflexe? Douleur au niveau de l'oreille, ça c'est otalgie. C'est quoi une otodémie? Si on a une atteinte de l'oreille, c'est une otodémie.

Otodémie, douleur due à une lésion de l'appareil, douleur de lésion de l'appareil, c'est une otalgie réflexe. Si atteinte de la sphère ORL, oui c'est atteinte de la sphère ORL et l'oreille est tout à fait normale. C'est une otalgie réflexe.

(32:12 - 33:40)

Alors définition douleur ressentie au niveau de l'oreille, deux situations. Lorsque j'ai une lésion au niveau de l'oreille, c'est une otodémie. Lorsque la lésion existe au niveau de la sphère d'ORL avec un examen de l'oreille normal, c'est une otalgie réflexe.

Donc il y a deux éléments au niveau de l'otalgie réflexe qu'il faut faire sortir. Lésion au niveau de la sphère ORL mais examen de l'oreille tout à fait normal. Bien sûr après l'anamnèse, en quoi consistera l'examen d'un patient qui se plaint d'une otalgie? Premièrement, il faut examiner cet appareil auditif cherchant à rattacher l'otalgie à l'appareil.

Donc examen du pavillon, on peut avoir par exemple la note émetant ou l'examen otoscopique qui va permettre de voir le conduit et bien sûr la membrane tympanique. Et il ne faut pas oublier dans cet examen clinique d'examiner la cavité buccale et le pharynx parce qu'une lésion peut siéger à ce niveau-là. L'examen de l'hypopharynx et du larynx en laryngoscopie indirecte,

examiner le cavon parce que le cavon peut être à l'origine d'une otalgie et puis l'examen de l'articulé dentaire parce qu'on peut avoir une perturbation de l'articulation temporomandibulaire et qui engendrerait une douleur de l'oreille et puis l'examen de toutes les paires crâniennes surtout dans le cadre des douleurs névralgiques.

(33:43 - 34:02)

Alors dans ce cadre-là, je vais vous donner quelques cas cliniques. Enfant de 5 ans qui se plaint d'otalgie droite depuis 48 heures avec fièvre sans otorré. L'otoscopie, vous avez ici l'oreille droite, ici l'oreille gauche et lorsque l'on lui fait l'examen ORL complet, on trouve qu'elle est normale.

(34:03 - 35:11)

S'agit-il d'une otalgie réflexe ou d'une otodynïe ? On a une otalgie avec une membrane tympanique inflammée, ça veut dire que c'est une otodynïe et en plus je vous dis que l'examen ORL est tout à fait normal donc ce ne peut pas être autre chose qu'une otodynïe, j'ai une membrane tympanique touchée. Alors quelle est l'étiologie de cette otalgie ? Bien sûr je serais capable d'interpréter inflammation sur le manche du marteau avec bien entendu un bombement relatif de la membrane tympanique, c'est une otite moyenne aiguë. Deuxième situation, un enfant de 15 ans qui se plaint d'une otalgie bilatérale depuis 48 heures avec fièvre sans otorré, on l'examine à l'otoscopie, voilà ce qu'on voit, des membranes tympaniques tout à fait normales.

(35:12 - 36:45)

S'agit-il d'une otalgie réflexe ou d'une otodynïe ? Dans ce cadre là, du moment que les membranes tympaniques sont tout à fait normales, c'est une otodynïe, ce n'est pas, c'est une otalgie réflexe, c'est-à-dire c'est une otalgie réflexe et bien sûr là je n'ai pas mis quels sont les résultats de l'examen clinique parce que l'examen de l'oropharynx montre ce que vous voyez sur la photo. Alors qu'est-ce qu'il présente ce patient ? Une angine, donc une angine est une des étiologies qui donnera une otalgie réflexe et les membranes tympaniques sont tout à fait normales. Concernant maintenant les otorés, alors les otorés, c'est quoi en fait une otoré ? C'est quoi l'otoré ? C'est une issue de liquide par le conduit auditif externe, c'est une issue de liquide par le conduit auditif externe, voilà c'est tout simplement ça, un liquide sort par le conduit auditif externe.

(36:46 - 40:12)

Bien sûr une anamnèse doit être requise, cette anamnèse va viser la nature du liquide, les conditions qui ont entraîné à ce que ce liquide sort de l'oreille, ce qu'il y a une notion de traumatisme, une manipulation du conduit, etc. Mais en quoi consistera l'examen clinique ? Il consistera d'une part à l'examen de l'otoré, vous voyez sur la diapositive sur votre gauche une otoré purulente et sur votre droite une otoré muqueuse. On peut avoir aussi une otoré

liquidienne séreuse par exemple ou bien parfois on peut avoir une otoré teintée de sang ou franchement sanglante.

L'examen par la suite va concerner l'examen du pavillon de l'oreille et aussi l'examen otoscopique, l'examen du pavillon de l'oreille à la mobilisation surtout dans le cadre des otites externes et bien sûr l'examen otoscopique en examinant le conduit auditif externe et la membrane tympanique à la recherche d'une perforation. Alors vous avez dans ce cadre là des situations cliniques, un enfant de dix ans qui se plaint d'otalgie d'une otoré droite récidivante depuis l'âge de huit ans à l'occasion de baignades et des épisodes de rhinopharyngite aiguë sans fièvre ni vertige. Il présente un problème à droite et l'otoscopie montre une perforation tympanique, vous voyez là la membrane tympanique étant perforée avec issue de pus au travers de la perforation.

Le reste de l'examen clinique est tout à fait normal. Alors quelle est à votre avis l'étiologie de cette otoré ? C'est facile, c'est une otite moyenne chronique avec perforation tympanique et une inflammation, infection au niveau de la caisse du tympan qui a engendré l'écoulement des sécrétions pérulantes au travers de la perforation. On ne parlera pas ici de la thérapeutique qu'on pourra voir éventuellement en 5e année.

On passera rapidement, je voudrais voir, on passera rapidement au dernier cours en rapport avec ces cours de sémiologie qui est en relation avec les vertiges. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent concernant l'essurdisté, l'otalgie et l'otoré ? Très bien, alors si vous n'avez pas de questions, on va passer à la suite. C'est quoi un vertige ? Quelle est la définition d'un vertige ? Otoré, séreuse et aqueuse, même chose.

(40:13 - 46:49)

Aqueuse est beaucoup plus fluide mais on peut confondre les séreuse et aqueuse. Quelle est la définition d'un vertige ? Illusion de mouvement. C'est en fait illusion de mouvement, c'est facile, mais la meilleure réponse est la suivante.

C'est une sensation erronée de déplacement du corps par rapport à l'espace ou de l'espace par rapport au corps. C'est en fait une illusion de mouvement, mais il faut l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Une sensation erronée de déplacement du corps par rapport à l'espace ou de l'espace par rapport au corps.

Après l'anamnèse, en quoi consiste l'examen d'un patient se plaignant des vertiges ? Un patient qui a un vertige, qu'est-ce qu'il faut chercher chez lui ? Autoscopie. En quoi consiste l'examen d'un vertigineux ? Tout d'abord on a un examen auditif, ensuite un examen vestibulaire, ensuite un examen neurologique et des paires crâniennes et ensuite un examen général. L'examen auditif concernera l'examen autoscopique avec une acoumétrie instrumentale cherchant est-ce qu'il y a ou pas une surdité.

Bien sûr après l'interrogatoire aussi. L'examen vestibulaire recherchera le nystagmus. C'est

quoi ce nystagmus ? Ce sont des mouvements saccadés simultanés, des deux yeux avec une phase rapide et une phase lente et le sens du nystagmus étant le sens de la phase rapide.

Rechercher un nystagmus spontané est provoqué. Un nystagmus spontané en tenant la tête du patient et en regardant les yeux au travers de lunettes grossissantes, de fringelles, est provoqué en essayant de réaliser des mouvements de la tête pour voir, pour réveiller un nystagmus. Ensuite on doit faire un examen de Remberg et bien sûr une épreuve de piétinement recherchant une déviation segmentaire.

L'examen neurologique des paires crâniennes est fondamental dans le cadre du diagnostic d'un vertige à la recherche d'un déficit neurologique qu'il soit moteur ou sensitif. Rechercher un syndrome cérébelleux et rechercher une atteinte des paires crâniennes. Et bien sûr terminé toujours par un examen général somatique, focalisé sur l'appareil cardiovasculaire en pensant à une baisse de la tension artérielle surtout dans le cadre des hypotensions orthostatiques.

Comment différencier chez un patient qui a un vertige, un vertige périphérique d'un vertige central ? Vous avez un patient qui vous dit je sens que je bouge par rapport aux objets ou les objets bougent par rapport à moi, c'est une illusion de mouvement et par conséquent un vertige. Alors comment savoir est-ce que ce vertige est secondaire à une atteinte du vestibule ou des nerfs vestibulaires ou secondaire à une atteinte des centres ? J'attends vos réponses. IRM, non clinique.

On n'est pas à l'IRM maintenant. IRM c'est syndrome harmonieux, désharmonieux. Très bien, voilà alors comment différencier les choses ? C'est que un vertige périphérique donne un syndrome harmonieux par atteinte du vestibule ou des nerfs vestibulaires et à ce moment là on va voir que la déviation segmentaire et la phase lente du nystagmus ont le même sens.

La phase lente du nystagmus et la déviation segmentaire ont le même sens et le contraire va se voir dans le vertige central où le syndrome serait désharmonieux par atteinte des centres ou des voies centrales et à ce moment là la déviation segmentaire et la phase lente du nystagmus ont des sens différents. On ne va pas jusqu'à réaliser l'IRM pour pouvoir différencier un vertige périphérique d'un vertige central. C'est après qu'on ait eu des données sur le vertige, c'est-à-dire l'orientation vers le vertige central, qu'on sera amené à demander une imagerie pouvant chercher l'étiologie.

Vous avez ici un cas clinique de situation de vertige où le patient est âgé de 40 ans, qui n'a aucun antécédent, qui se plaint de sensations vertigineuses rotatoires, d'installation brutale depuis 48 heures, sans surdité, ni otorrhée, ni acouphènes, donc en d'autres termes des vertiges isolés. Lorsque on l'a examiné, on trouve une otoscopie tout à fait normale mais on trouve un nystagmus spontané horizontal battant à droite. L'épreuve de Weber montre une déviation segmentaire à gauche et l'examen neurologique montre une motricité sensibilité percrânienne tout à fait normale.

(46:50 - 53:39)

De quoi s'agit-il? D'un vertige périphérique ou d'un vertige central? Et pourquoi? Pourquoi c'est un vertige périphérique? Il y a un qui a répondu vertige périphérique, la moitié des étudiants vertige périphérique, l'autre moitié central. Alors expliquez-moi pour les gens qui ont dit central pourquoi c'est central et expliquez-moi pour les gens qui ont répondu périphérique pourquoi c'est périphérique. J'attends vos réponses.

La phase lente du nystagmus est du côté gauche. Parce que le nystagmus est à droite, donc sa phase lente est à gauche. Et alors syndrome harmonieux vu que le sens de la phase lente du nystagmus est vers le côté gauche, la déviation du corps est donc périphérique.

Réponse juste. C'est ça la réponse. Donc les gens qui ont dit que c'est central se sont trompés dans cette phrase là.

Un nystagmus horizontal battant à droite. Or j'ai déjà dit que le sens du nystagmus c'est la phase rapide. Et donc c'est le contraire.

Si le sens du nystagmus est à droite, ça veut dire que la phase lente est à gauche. Et donc voilà, c'est cette phrase là qui va vous permettre de répondre à la réponse juste. Donc c'est un vertige périphérique secondaire à une atteinte soit du vestibule soit des nerfs, bien sûr il faut faire d'autres explorations qui vont nous permettre de bien cerner la situation.

Bien alors je pense que nous avons terminé avec la révision de ce cours là de sémiologie ORL et je crois que je n'ai pas répondu à une question. Il y a une personne qui me dit c'est quoi une otite cholestéatomateuse. L'otite cholestéatomateuse est une otite moyenne chronique dangereuse par la présence de tissus épidermiques à l'intérieur de la caisse du tympan.

Parce que normalement dans la caisse du tympan il devrait y avoir de la muqueuse respiratoire et non pas de tissus épidermiques. Mais quand on a des tissus épidermiques à l'intérieur de la caisse du tympan cela engendrera la présence de squames et bien entendu d'enzymes qui vont détruire la chaîne du tympan et engendrer par la suite de graves dégâts sur l'appareil de transmission. Donc il va donner une surdité de transmission mais qui peut donner aussi d'autres complications.

On verra en cinquième année. Avez-vous d'autres questions sur les différentes questions que l'on vient de traiter? Les surdités, les otorrhées, les otalgies, les vertiges? Monsieur, pour les surdités mixtes, est-ce que les épreuves de Rhine-et-Vévert peuvent orienter dans le diagnostic? Oui. Ce qu'il faut savoir c'est que dans la surdité mixte la transmission prime et donc on aura dans une mixte une orientation vers le tissu atteint.

Est-ce que la déviation segmentaire gauche veut dire la tendance à chuter à gauche? Oui, au cours de l'épreuve de Romberg, bien sûr, déviation segmentaire. Oui, d'autres questions? Avez-vous d'autres questions? Est-ce que la déviation du nystagmus? Très bien, alors dans le nystagmus il y a deux phases, une phase lente et une phase rapide. Le mouvement saccadé, simultané des deux yeux avec une phase rapide et une phase lente et communément les

scientifiques se sont accordés pour dire pour pouvoir donner le sens d'un nystagmus on va dire la phase rapide.

Ce qui veut dire que lorsque je dis j'ai un patient qui a un nystagmus ça veut dire que sa lésion existe à gauche et que c'est vraiment la phase lente qui nous dit de quel côté existe la lésion. C'est ça l'explication. Oui, d'autres questions? Bien, alors si vous n'avez pas de questions, nous avons terminé avec le cours de révision ou de séance interactive concernant l'étude de sémiologie que je vous ai enseigné, bien entendu.

Très bien, vous avez des questions? Je vois qu'il n'y a personne qui crie donc bien sûr merci à vous aussi. Allez, au revoir et puis à bientôt. Merci monsieur.